3.临床表现 骨折后臀中肌收缩→牵拉大转子外旋,正常情况下有关节囊保护不会外旋

①腹股沟中点处压痛，外旋畸形 45-60°（老人爱在外面 xuan）

②下肢缩短/大转子上移：超过 Nelaton 线、Bryant 三角底边缩短＜5cm、Shoemaker 征（NBS 科比 5 个冠军）

③可合并股骨头坏死、脂肪栓塞

下肢的长骨骨折都易导致脂肪栓塞,下肢长骨骨干里是黄骨髓

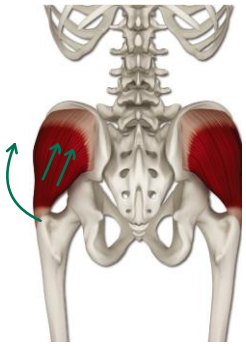




图 63-12 股骨颈骨折伤肢的外旋畸形

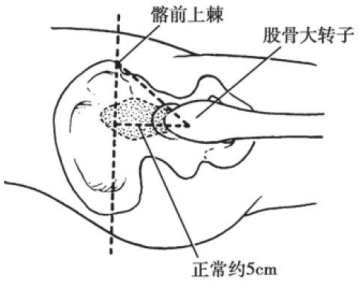


图 63-13 Bryant 三角

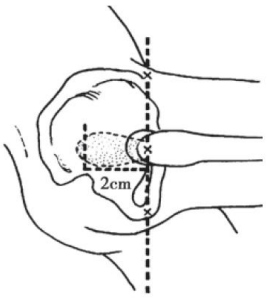
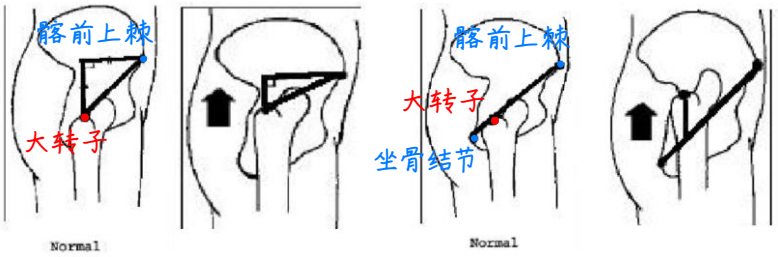


图 63-14 Nélaton 线



4.治疗

（1）老年

①全身情况差不耐受手术：防旋鞋（24 小时内能完成手术）、皮肤/胫骨结节牵引（24 小时内不能完成手术），待全身情况允许后尽快手术

②合并症多预期寿命短：半髋关节/股骨头置换术 只换股骨头,不换髋臼

③合并症少预期寿命长的 Garden III/IV型（有移位）：全髋关节置换术

预期寿命长,人工关节寿命只有10年左右,若只换股骨头,后期又与髋臼摩擦出现疼痛,所以全换好

（2）闭合复位（手法复位和器械复位）+螺钉内固定

针对年轻人、合并症少、预期寿命长、Garden I/II型的老年人

髋关节周围的肌肉比较强大,不做内固定易受肌肉牵拉移位

（3）注意前倾角的存在（12-15°）

股骨头坏死IV期:股骨头脱位,有继发的骨关节炎（也是全髋关节置换术）

VS肱骨近端骨折-老年人 Neer IV型:肱骨头置换术

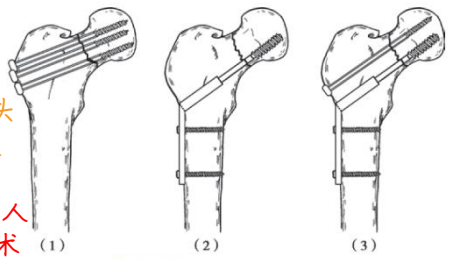


图 63-15 股骨颈骨折内固定方法

（1）空心拉力螺钉固定 （2）动力髋螺钉固定 （3）空心拉力螺钉与动力髋螺钉联合应用固定

转子易发生病变,如骨的囊性病变

（三）股骨转子/粗隆间骨折

①跌倒等外伤、病理性骨折，多见于中老年骨质疏松

②转子间压痛，下肢缩短、外旋畸形可达 90°，髋部肿胀和瘀斑多见（囊外骨折）

③手术 VS 股骨颈骨折:腹股沟压痛,下肢缩短,外旋畸形达45度~60度(关节囊限制外旋角度)

下肢缩短：股骨颈骨折、股骨转子间骨折、股骨干骨折、髋关节后脱位、部分髋关节前脱位等 部分骨盆骨折

外旋畸形45度~60度 外旋畸形可达90度 屈曲内收内旋畸形